

b 身体所見

表1に示すような疾患を念頭に fine crackles や coarse crackles などの呼吸副雑音や呼吸音の左右差などを確認する。

検 査

a 胸部X線, 胸部CT

呼吸器疾患診断のための胸部X線は必須である。早期の間質性肺炎や気管支拡張症は胸部X線では確認できない場合もあるので、所見がなくても必要に応じて胸部CTを撮影する。

b 血液検査

身体所見や画像所見から間質性肺炎が疑われる症例ではKL-6やサーファクタントプロテイン-D (SP-D)の上昇を確認する。また、肺癌の疑い例では腫瘍マーカー (CEA, CYFRA, ProGRP など) も参考になる。感染性心内膜炎などの感染症を疑った場合は血液培養が有用である。

c 喀痰検査

肺癌が疑われる場合は喀痰細胞診を提出する。感染症の合併に関して喀痰塗抹, 培養検査を提出する。

d 気管支鏡検査

腫瘍性病変の場合は気管支擦過, 経気管支生検 (transbronchial biopsy : TBB) や超音波気管支鏡ガイド下針生検 (endobronchial ultrasonography guided transbronchial needle aspiration : EBUS-TBNA) を, 間質性陰影では気管支肺胞洗浄 (bronchoalveolar lavage : BAL) や経気管支肺生検 (transbronchial lung biopsy : TBLB) を行う。

表1 後天的なバチ指を随伴する病態

1. 胸腔内の腫瘍性病変
 - 肺癌
 - 胸膜中皮腫
 - 胸膜線維腫
 - 転移性骨肉腫
2. 胸腔内の化膿性疾患
 - 肺膿瘍
 - 気管支拡張症
 - 嚢胞性線維症
 - 膿胸
 - 慢性空洞性の抗酸菌感染または真菌感染
3. びまん性肺疾患
 - 特発性肺線維症
 - 石綿肺
 - 肺動静脈奇形
4. 心血管疾患
 - チアノーゼ性先天性心疾患
 - 感染性心内膜炎
 - 動脈グラフトの感染
 - 気管支動静脈瘻
 - 片麻痺性脳卒中
5. 消化管疾患
 - 炎症性腸疾患
 - セリアック病
6. 肝胆道系疾患
 - 肝硬変 (特に胆汁性および若年性)
7. 代謝性疾患
 - 甲状腺性肢端肥大症

[Myers KA, et al : JAMA 286 : 341, 2001 より引用]

文 献

- 1) McGee S : Evidence-Based Physical Diagnosis, 2nd Ed, Saunders, p303, 2007
- 2) Stavem P : Lancet 2 (1088) : 7, 1959
- 3) Schamroth L : S Afr Med J 50 : 297, 1976
- 4) Myers KA, et al : JAMA 286 : 341, 2001
- 5) Dickinson CJ, et al : Lancet 2 (8573) : 1434, 1987
- 6) Spicknall KE, et al : J Am Acad Dermatol 52 : 1020, 2005